

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : عبير فهمى شلبى الشربينى

المحافظة : الغريبه الحي / المدينة : المحله الكبرى العنوان : الجابريه

رقم البطاقة : 27505031601629 رقم التليفون : 01110223403 تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 03-05-1975 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمى وتلطيفى [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقع:

التوقع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطـة العـلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدیر عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عبير فهمي شلبي الشربيني National ID: 27505031601629	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Patient Name: Abeer Fahmy Shalabi Al Sherbiny	Date : 19/07/2025
Exam : Item 1	Age : 50 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 43314

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Known case of breast cancer showed:
- Left upper lobar anterior segment subpleural reticulations with few atelactatic bands likely post therapeutic changes.
- Otherwise, Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No Intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton:** no definite worrisome lytic or sclerotic focal lesions.

Opinion:

- Left upper lung lobe anterior segment subpleural reticulations with few atelectatic bands likely post therapeutic changes.
- No evidence of pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.

Signature Dr.Mohamed Hassan
23/07/2025 04:07



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



BRCA 2 +ve

Patient ID:

Name: محمد فهمي شبيب الشرباش

Sex:

MDT form

3- Medical numbers:
Female

83172118

Old Med:

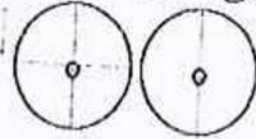
Old Med

4234/2023

2-ID number: 27505031601629



Patient Age: 49 Y



Best-NAC
clinical

Family history

Family history
+VE

Phone

Phone
01065810262

BMI

BMI
29

Marital status

Marital status
Married

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP
A

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST NAC

Co morbidity

Co morbidity
HTN

Menopausal status

Menopausal status
Menopausal

Initial STAGE

Initial STAGE

Date of MDT

Date of MDT

15/05/2024

Breast Imaging:

Lt breast 3 o'clock BIRADS 4b

Clinical data

Mets Workup:

CT CAP: free

DX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
ER COMMENT -VE	ER COMMENT -VE	PR COMMENT -VE	Her 2 Neu COMMENT -VE	SISH COMMENT	80%

T	N	M
2	0	0

Sonogramography

PATIENT HISTORY

1-CESM: Re MDT after CESM (if unifocal for clip insertion)

2- ECHO

3- Labs

4- BRCA testing

Pt will be for NACT (AC* 4 then taxol/Carb*12)

MDT OUTCOME & PLAN

for wire localization the WLE & SLNB (central quadrenectomy)

Pt is BRCA 2 mutant

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

د. فهد لاذي

SIGNATURE

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

د. هبة جابر

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

د. هبة جابر

Patient Name : الأمينة / عزيزة محمد شادي الشربيني
Patient No. : 27505031601629
Path No. : 1745/24
Sex : Female
Age : 49 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001202
Request Date : 26/05/2024
Verification Date : 02/06/2024
Financial Category : اورام نازع السلام - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature of specimen: Left WLE & left SLNB

Gross examination:

• Procedure: Left BCS

Fibrofatty tissue piece measured 15x8x6 cm with covering skin ellipse measured 12x4 cm.

• Tumor extent : A greyish white tumour bed site

• Size: 5x3x2 cm.

• Skin involvement: Unremarkable grossly.

• Distance from margins: 1 cm away from least deep margin

• Frozen section: Free margins & free SLNB (0/4)

Microscopic examination:

• Histological type: No residual tumor tissue

• Ductal carcinoma in situ: No

• Lymph nodes: Free (0/4)

• Skin involvement: Free

• Resection margins: Free margins

• Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Dignosis:

Left WLE & Left SLNB (post NACT) :

No residual tumor tissue

• Free margins

• Free lymph nodes (0/4)

• Pathologic complete response (PPR)

• Stage : ypT0, N0

Dr. Rana Fathy
Dr. Heba Hassan

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 22/06/2024 08:56:55

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy

CAP

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - نيلز النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Miss El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Abeer Fahmy Shalabi Al Sherbiny	Date : 24/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 27505031601629	Pat. ID: 43314

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

- Mastalgia
- Positive family history (sister)

Report:

- Heterogeneous fibroglandular parenchyma (ACR c)
- Left Breast:
 - Ill-defined equally dense obscured lesion is seen in the para-areola region at 3O'clock extending retro-areola with suspected intra-duct extensions reaching the nipple. By ultrasound it is seen as an ill-defined hypoechoic irregular mass measuring 30x25x20mm about 8mm from the skin. Peripheral vascularity of equivocal RI = 0.6 is noted.
 - No pathological enlarged axillary, infra or supraclavicular lymph nodes.
- Right Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary L.N.

Opinion:

- Left breast suspicious mass likely neoplastic (BIRADS 4b) for histopathological examination.
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS I)

Best regards,

Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCL, Cairo University
24/10/2023 11:41 AM

Patient's Name: Abeer Fahmy Shalaby El Sherbini
Date: 2026-05-30
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

INDICATION:
Left CBS

TECHNIQUE:
• Bilateral MLO and CC views
• Bilateral U/S

REPORT:

- Dense parenchyma, (ACR C), with focal disruption seen underlying the scar site.
- No suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary U/S showed no solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Right nonspecific axillary nodes are seen
- Free left axillary region as well as the infra and supra-clavicular regions.

OPINION:

- Normal study of the right breast, (BIRADS 1).
- Left post-operative changes,(BIRADS 2).

Best regards,
Dr. Yara Mohamed, MD